

Narrativas Tecnológicas

Mujer, 50 años — Enfermera jefa, sector público

¿Hay alguna tecnología que haya cambiado tu vida significativamente?

En lo profesional, los sistemas de ficha electrónica. Eso cambió completamente cómo trabajamos en el hospital. Antes la ficha era en papel, y te imaginas lo que eso implica: buscar, encontrar, perder, completar a mano. Ahora todo está digitalizado. Tiene sus problemas también, cuando el sistema cae es un caos total, pero en general es un avance enorme. Y en lo personal, el celular, como todo el mundo supongo.

¿Qué entiendes por tecnología?

Lo que sé es que en salud la tecnología salva vidas, eso lo veo todos los días. Un escáner, un marcapasos, los equipos de ventilación. Para mí eso es tecnología en su sentido más concreto y más humano. Pero también los medicamentos, los protocolos de atención que se basan en investigación... todo eso es tecnología aunque no tenga pantalla. Lo que dejaría fuera... no sé, quizás las cosas que no tienen un fin práctico claro. Aunque no me gusta ser tan pragmática.

¿Crees que la tecnología tiene un propósito?

Debería tener el propósito de mejorar la vida de las personas. Eso es lo que yo creo. Pero no siempre es así. A veces parece que el propósito es hacer dinero, nada más. Yo lo veo en salud con los medicamentos, hay tratamientos que existen pero que son inaccesibles porque las farmacéuticas los patentan y los venden a precios imposibles. Ahí la tecnología existe pero su propósito no es salvar vidas, es generar ganancias.

¿Podríamos vivir sin ciertas tecnologías?

Hay pacientes míos que literalmente no podrían vivir sin ciertas tecnologías. Diálisis, ventilación mecánica, medicamentos de uso crónico. Eso zanja la discusión para mí. Hay tecnologías que ya son parte de la vida humana de manera irreversible. Y otras que son más prescindibles. Podríamos vivir sin TikTok, no podríamos vivir sin la insulina.

¿Crees que la tecnología puede resolver problemas como la pobreza o la desigualdad?

La desigualdad en salud la vivo de cerca. Y te digo que no es un problema tecnológico. Es un problema de quién tiene acceso a qué. Hay tecnología médica excelente en el sistema privado que en el sistema público simplemente no llega. La tecnología existe, lo que no existe es la voluntad de distribuirla equitativamente.

Entonces, la tecnología sola no resuelve nada si no va acompañada de políticas que aseguren el acceso.

¿Quién crees que decide cómo se desarrolla la tecnología?

En salud, bastante el mercado y bastante la academia. Las grandes investigaciones las financian empresas farmacéuticas que luego tienen derechos sobre los resultados. Hay enfermedades de países pobres que casi no tienen investigación porque no hay mercado suficiente. La gente se muere de enfermedades para las que no hay vacuna porque no hay incentivo económico para desarrollarla. Eso me parece una aberración, pero es la realidad del sistema.

¿Hay alguna tecnología que te preocupe?

La inteligencia artificial en diagnóstico médico me genera mucha ambivalencia. Por un lado, puede detectar cosas que el ojo humano no detecta, puede procesar información enorme. Por otro lado, me preocupa la deshumanización del cuidado. La medicina no es solo diagnóstico, es también contención, es mirar a los ojos al paciente, es la confianza. Si eso se reemplaza por un algoritmo, perdemos algo fundamental. Creo que hay que usarla con mucho cuidado y sin perder de vista que tratamos personas, no datos.